ADEGUAMENTO TRACCIATO RECORD - MONITORAGGIO ASSISTENZA DOMICILIARE *(rif. DM 7 agosto 2023) - aggiornamento giugno 2024*

A. TRACCIATO DATI ANAGRAFICI (un solo record per evento assistenziale di CD)

	Nr. Rif. Campo	Chiave tab.	Obbligatorio	Descrizione campo	Lunghezza	Posizione iniziale	Tipo Dato	Obbligatorio NSIS-ADI	Istruzioni per la codifica
	1.1	**X**	SI	**Azienda ULSS erogatrice**	3	1	AN	SI	Codice dell'azienda ULSS erogatrice es. 501 ,….,509
	1.2		SI	**Codice fiscale o altro Identificativo Utente**	20	4	AN	SI	Il campo va valorizzato con il Codice Fiscale per tutte le schede riferite a cittadini italiani. Per i cittadini stranieri, qualora non in possesso del Codice Fiscale, vanno indicati in alternativa tra loro il codice TEAM (Tessera europea assicurazione malattia) , o il codice ENI (Europei non iscritti), o il codice STP (Straniero temporaneamente presente) per cittadino straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.
	1.3		SI	**Tipo identificativo utente**	1	24	AN	SI	1. Codice fiscale 2. Codice ENI 3. Codice STP 4. Codice ID utente della Tessera Europea d'Assicurazione Malattia (TEAM) 5. Altro identificativo **6. Soggetto che ha richiesto l'anonimato nei casi previsti dalla legge** 9. Identificativo non disponibile
	1.4		NO (1*)	**Codice istituzione pagatrice TEAM (tessera europea)**	28	25	AN	NBB	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Campo nr. 7 tessera Team). Obbligatorio per tipo identificativo utente 4
	1.5		NO (1*)	**Data scadenza tessera TEAM**	8	53	D	NBB	Indicare la data di scadenza della tessera TEAM per i cittadini comunitari non italiani. Utilizzare il formato GGMMAAAA. (Campo nr. 9 tesssera Team). Obbligatorio per tipo identificativo utente 4
	1.6		NO	**MPI - Master Patient Index**	28	61	N	NO	Master Patient Index (Id regionale della posizione anagrafica). Chiave di identificazione univoca con cui la posizione anagrafica è stata censita in ambiente regionale (Anagrafe Unica). Disponibile per i residenti e assistiti in Regione Veneto come servizio erogato dalla anagrafe unica regionale: progressivamente diventerà il riferimento anagrafico per la gestione dei flussi informativi per gli assistiti. Fino a diversa indicazione la compilazione è facoltativa.
	1.7		NO	**Codice sanitario**	9	89	N	NO	Il campo va valorizzato, in combinazione con il codice fiscale, per i soli residenti in Veneto.
	1.8		NO	**Cognome**	30	98	AN	NO	Il campo va valorizzato, in combinazione con il codice fiscale, obbligatorio quando non disponibile il codice fiscale
	1.9		NO	**Nome**	20	128	AN	NO	Il campo va valorizzato, in combinazione con il codice fiscale, obbligatorio quando non disponibile il codice fiscale
	1.10		SI	**Sesso**	1	148	N	SI	Utilizzare i codici seguenti: 1 - maschio, 2 - femmina.
	1.11		SI	**Data di nascita**	8	149	D	SI	Utilizzare il formato GGMMAAAA.
Residenza e domicilio	*1.12*		SI	**Comune o Stato Estero di nascita**	6	157	AN	SI	Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
	1.13		SI	**Cittadinanza**	3	163	AN	SI	Identifica la cittadinanza dell'assistito alla fine del periodo di riferimento della rilevazione. Per i cittadini italiani codificare con 100. Per gli apolidi codificare 999.
	1.14		SI	**Comune o Stato Estero di residenza**	6	166	AN	SI	Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
	1.15		SI	**Azienda ULSS di residenza**	6	172	AN	SI	Utilizzare il formato RRRUUU; RRR = codici ISTAT delle regioni UUU = codice azienda sanitaria
	1.16		SI	**Comune di domicilio**	6	178	AN	NO	Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia.
	1.17		SI	**DSS di domicilio**	1	184	N	NO	Codice del distretto relativo al comune di domicilio
	1.18		NO	**Codice MMG/PLS**	16	185	AN	NO	Codice fiscale del MMG o PLS.
Altri dati anagrafici	*1.19*		SI	**Stato Civile**	1	201	N	SI	Indica lo stato civile dell'assistito al momento della rilevazione: 1 - celibe/nubile, 2 - coniugato, 3 - separato, 4 - divorziato, 5 - vedovo, 9 - non dichiarato.
	1.20		SI	**Nucleo Familiare**	2	202	N	SI	Indica il numero dei componenti del nucleo familiare convivente, escluso l'assistito e l'eventuale assistente non familiare convivente (rientrano nel conteggio ad esempio: coniuge/partner convivente, figlio/a, fratello/sorella, nipote, genero/nuora, cognato/a).
	1.21		SI	**Assistente Non Familiare**	1	204	N	SI	Asssitenza a pagamento fornita da una o più persone non appartenenti al nucleo familiare: 1 – occasionale, 2 – fino a 1h/giorno, 3- da 1 a 4 h/giorno, 4- da 4 a 8 h/giorno; 5- presenza notturna, 6 - assistenza continuativa, 7 – non presente.
	1.22		NO	**Titolo di studio**	1	205	N	NO	1 – nessuno, 2 – licenza elementare, 3 – licenza media inferiore, 4 – diploma media superiore, 5 – diploma universitario, 6 – laurea, 7 – scuola professionale, 8 – altro
	1.23	**X**	SI	**Identificativo evento assistenziale di CD**	12	206	N	SI	Numero che identifica univocamente l' evento assistenziale di CD (pazienti diversi non possono avere lo stesso identificativo dell'evento assistenziale). Tale campo è necessario per riunire il file Anagrafico agli altri file del flusso, separati per il trasferimento dei dati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. E' obbligatorio associare ad ogni evento assistenziale di CD lo stesso codice nel tempo, per correlare efficacemente i record relativi alla stesso episodio di presa in carico.
	1.24		NBB	**Responsabilità Genitoriale**	1	218	N	NBB	Indica chi ha la responsabilità nei confronti dell'assistito se minorenne. Il campo deve essere valorizzato se l'età dell'assistito (anno della data presa in carico -anno di nascita) è minore o uguale a 17. I valori ammessi: 1 - materna, 2 - paterna, 3 - condivisa, 4 - da tutore, 5 - struttura pubblica o convenzionata, **9 - non disponibile***

(1*) Obbligatorio per tipo identificativo utente = 4

			B1 TRACCIATO VALUTAZIONE, RIVALTAZIONE E CONCLUSIONE (almeno un record per ogni evento assistenziale di CD nel periodo in esame) - almeno 1 record prima valutazione							
		Nr. Rif. Campo	Chiave tab.	Obbligatorio *	Descrizione campo	Lunghezza	Posizione iniziale	Tipo Dato	Obbligatorio NSIS-ADI	Istruzioni per la codifica
		2.1	**X**	SI	**Identificativo evento assistenziale di CD**	12	1	N	SI	Ricollega il servizio erogato all'evento assistenziale di CD (vedi TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
	Evento assistenziale di CD	*2.2*		SI	**Soggetto richiedente cure domiciliari**	2	13	N	SI	Indica il soggetto richiedente la evento assistenziale di CD INIZIALE. I valori ammessi sono i seguenti: 1 - servizi sociali Comune, 2 - servizi sociali Az. ULSS, 3 - MMG/PLS, 4 - Ospedale, 5 - Struttura residenziale extraospedaliera, 6 - Utente/familiari, 7 - Apertura amministrativa per riassetto territoriale ASL, 8 - Apertura amministrativa della stessa Persona presa in carico, 9 - altro, 10 - Hospice, 11 - Servizi territoriali/distrettuali, 12 - Medico specialista, 13 - Ambulatorio cure palliative, 14 Ospedale per dimissione protetta.
		2.3		SI	**Tipologia Presa in Carico**	1	15	N	SI	Indica la tipologia di presa in carico. I valori ammessi sono i seguenti: 1 - Cure domiciliari (DPCM 12 gennaio 2017 art. 22), 2 - UCPDOM
		2.4		SI	**Data di inizio dell'evento assistenziale di CD**	8	16	D	SI	Indica la data dell'attuale evento assistenziale di CD (non varia fino alla chiusura dell' evento assistenziale di CD).
		2.5		NBB	**Pianificazione condivisa delle cure in cartella/fascicolo**	1	24	N	NBB	Indica se esiste una pianificazione condivisa delle cure in cartella/fascicolo ai sensi della l.219/2017 art. 5. Valori ammessi: 1 - Si, 2 - No, **9- non disponibile*** **NBB: Il campo deve essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM.**
Evento assistenziale di CD / chiusura	Conclusione	*2.6*		NBB	**Data conclusione**	8	25	D	SI	Indica la data di conclusione della evento assistenziale di CD dell'assistito.
		2.7		NBB	**Motivo conclusione**	2	33	N	SI	Il campo ha dominio condizionato dal tipo presa in carico. Valori ammessi sono: 1 - Completamento del programma assistenziale, 2 - Ricoveri in ospedale, 3 - Decesso a domicilio, 4 - Decesso in ospedale, 5 - Trasferimento in struttura residenziale, 6 - Trasferimento in Hospice, 7 - Decesso in Hospice, 8 - Trasferimento in altra tipologia di cure domiciliari, 9 - Cambio residenza, 10 - Cambio medico, 11 - Volontà dell'utente, 12 - Chiusura amministrativa (in assenza di sospensione, qualora non vi siano prestazioni per 3 mesi), 13 - Passaggio dalla rete pediatrica alla rete adulti e viceversa, 80 - trasferimento in altra struttura residenziale/intermedia, 82 – Decesso (se non rientra nei casi precedenti), 88 – Trasferimento (se non rientra nei casi precedenti), 97 - Chiusura amministrativa per riassetto territoriale ASL, 98 - Chiusura amministrativa con riapertura nell'anno successivo in assenza di sospensione, 99 - altro **NBB: obbligatorio se DATA_CONCLUSIONE valorizzata** **Codice 10 non valido per prese in carico di tipo UCPDOM** **Codice 13 non valido per prese in carico di tipo Cure Domiciliari**
sintesi clinico funzionale	Riferimento valutazione	*2.8*		SI	**Tipo valutazione**	1	35	N	SI	valori ammessi: 1 - valutazione iniziale (per ogni nuovo evento assistenziale di CD), 2 - rivalutazione.
		2.9		SI	**Data valutazione**	8	36	D	SI	Indica la data nella quale è stata effettuata la valutazione iniziale oppure una rivalutazione (data ultimo aggiornamento di un qualsiasi elemento di valutazione:diagnosi, svama/scheda valutazione semplificata, scheda bisogni) relativa all'episodio di assistenza in corso. Utilizzare il formato GGMMAAAA
	Rif. UVMD	*2.10*		NO	**Data ultima UVMD**	8	44	D	NO	indicare la data dell'ultima UVMD (anche se fatta nei periodi precedenti). Utilizzare il formato GGMMAAA
	Patologie	*2.11*		SI	**Patologia Prevalente**	3	52	AN	SI	Codice ICPC della diagnosi "principale" (quella che condiziona maggiormente il piano di assistenza).
		2.12		SI	**Patologia Concomitante**	3	55	AN	SI	Codice ICPC della patologia concomitante in grado di condizionare la evento assistenziale di CD, se non è presente inserire il codice 000.
	Scheda valutazione semplificata	*2.13*		SI	**Profilo cognitivo (PCOG)**	1	58	N	SI	da Svama completa o scheda di valutazione multidimensionale semplificata: 1 - lucido, 2 - confuso, 3 - molto confuso o stuporoso.
		2.14		SI	**Disturbi comportamentali**	1	59	N	SI	da NPI o scheda di valutazione multidimensionale semplificata: 1 - assenti / lievi, 2 - moderati, 3 - gravi.
		2.15		NO	**Disturbi sensoriali**	1	60	N	NO	per flusso riabilitazione territoriale: 1 - assenti / lievi, 2 - moderati, 3 - gravi.
		2.16		NO	**Disturbi della comunicazione**	1	61	N	NO	per flusso riabilitazione territoriale: 1 - assenti / lievi, 2 - moderati, 3 - gravi.
		2.17		SI	**Profilo mobilità (PMOB)**	1	62	N	SI	Indica il livello di autonomia dell'assistito nell'area di mobilità condizionato all'età - a partire dai 3 anni. Da Svama completa o scheda di valutazione multidimensionale semplificata: 1 - si sposta da solo, 2 - si sposta assistito, 3 - non si sposta. **NBB: Il campo deve essere valorizzato se l'età dell'assistito (anno della data presa in carico -anno di nascita) è maggiore o uguale a 3**
		2.18		SI	**Profilo funzionale (PADL)**	1	63	N	SI	Indica il livello di autonomia dell'assistito nell'area di mobilità condizionato all'età - a partire dai 6 anni. Da Svama completa o scheda di valutazione multidimensionale semplificata: 1 - autonomo o quasi, 2 - dipendente, 3 - totalmente dipendente. **NBB: Il campo deve essere valorizzato se l'età dell'assistito (anno della data presa in carico -anno di nascita) è maggiore o uguale a 6**
		2.19		NO	**Profilo sanitario (PSAN) (necessità di assistenza sanitaria)**	1	64	N	NO	da Svama completa o scheda di valutazione multidimensionale semplificata: 1. bassa, 2. intermedia, 3. alta.
		2.20		SI	**Profilo socio-assistenziale (PSOC)**	1	65	N	SI	da Svama completa o scheda di valutazione multidimensionale semplificata: 1 - ben assistito, 2 - parzialmente assistito, 3 - non sufficientemente assistito.
		2.21		SI	**Fragilità Familiare**	1	66	N	SI	Indica la presenza di Fragilità familiare. Valore ammessi: 1 - presente, 2 -assente **, 9- non disponibile***
	Scheda Bisogni e problemi di salute	*2.22*		SI	**Problemi di salute / bisogni assistenziali**	70	67	T	SI	problemi di salute allineato con DM 17-12-2008; Codificare in questo modo: "1" in caso di problema presente, "2" in caso di problema assente. La posizione del carattere si riferisce al "bisogno assistenziale" secondo la tabella allegato D - Bisogni_NEW I caratteri delle posizione 61-70 (bisogni "vuoti") vanno compilate con il carattere 2.
		2.23		SI	**Rischio sanguinamento acuto**	1	137	N	SI	Indica se l'assistito è a rischio sanguinamento acuto. Valori ammessi: 1 - Si, 2 - No, **9- non disponibile***
	Servizi a periodo	*2.24*		NO	**Forniture sanitarie attive nel periodo**	12	138	T	NO	Codificare in questo modo:"1" in caso di servizio presente nel periodo"; "2" in caso di servizio assente nel periodo". **La posizione del carattere si riferisce alla tipologia del servizio erogato**: 1 - farmaceutica ad erogazione diretta, 2 - assistenza protesica, 3 - fornitura O2 liquido, 4 - fornitura O2 concentratore, 5 - fornitura O2 in bombole, 6 - fornitura materiale per dialisi, 7 - fornitura alimenti per nutrizione enterale, 8 - fornitura presidi per nutrizione parenterale, 9 - fornitura materiale sanitario di consumo (es. medicazioni), 10 - altro.
		2.25		NO	**Interventi del servizio di assistenza domiciliare (*)**	4	150	T	NO	Codificare in questo modo:"1" in caso di servizio presente nel periodo"; "2" in caso di servizio assente nel periodo". **La posizione del carattere si riferisce alla tipologia del servizio erogato:** 1 - prestazioni quotidiane di base - Attività di aiuto alla persona, 2 - prestazioni quotidiane di base - Attività tese a favorire la deambulazione e/o mobilizzazione della persona, 3 - prestazioni quotidiane strumentali, 4 - altre prestazioni.
		2.26		NO	**Interventi a sostegno della domiciliarità**	4	154	T	NO	Codificare in questo modo:"1" in caso di servizio presente nel periodo"; "2" in caso di servizio assente nel periodo". **La posizione del carattere si riferisce alla tipologia del servizio erogato:** 1 - telesoccorso, 2 - pasti a domicilio, 3 - trasporto / accompagnamento, 4 - contributo economico straordinario.
		2.27		NBB	**Appartenente alla rete**	1	158	N	NBB	Indica se l'erogatore appartiene alla rete. Valori ammessi:1 - Si, 2 - No, **9 - non disponibile** **NBB: Il campo deve essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM.**
		2.28		NBB	**Tipo rete**	1	159	N	NBB	Indica a quale rete appartiene l'erogatore. Valori ammessi:1 - RLCP (rete locale di cure palliative), 2 - RCPPTD (rete di cure palliative pediatriche e terapia del dolore), 3 - RLTD (rete locale di terapia del dolore), **9 - non disponibile*** **NBB: Il campo deve essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM e se l'erogatore appartiene alla rete**

2.29		NBB	**Segno/Sintomo clinico 1**	5	160	AN	NBB	I valori ammessi sono riportati nella tabella di riferimento 5.1 (ICD 9 CM) **NBB: Il campo deve essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM**

Valutazione UCPDOM	*2.30*		FAC	**Segno/Sintomo clinico 2**	5	165	AN	FAC	I valori ammessi sono riportati nella tabella di riferimento (ICD 9 CM) **Il campo può essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM**
	2.31		FAC	**Segno/Sintomo clinico 3**	5	170	AN	FAC	I valori ammessi sono riportati nella tabella di riferimento (ICD 9 CM) **Il campo può essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM**
	2.32		FAC	**Segno/Sintomo clinico 4**	5	175	AN	FAC	I valori ammessi sono riportati nella tabella di riferimento (ICD 9 CM) **Il campo può essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM**
	2.33		FAC	**Segno/Sintomo clinico 5**	5	180	AN	FAC	I valori ammessi sono riportati nella tabella di riferimento (ICD 9 CM) **Il campo può essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM**
	2.34		NBB	**Utilizzo Strumento identificazione bisogno CP presente in cartella/fascicolo**	1	185	N	NBB	Valori ammessi: 1 - Si, 2 - No, **9- non disponibile*** **NBB: Il campo deve essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM.**
	2.35		NBB	**Utilizzo Strumento valutazione multidimensiona le presente in cartella/fascicolo**	1	186	N	NBB	Valori ammessi: 1 - Si, 2 - No, **9- non disponibile*** **NBB: Il campo deve essere valorizzato solo in caso di tipo presa in carico UCPDOM.**
	2.36	**X**	SI	**Chiave Progressivo record**	12	187	N	NO	Identificativo univoco assoluto per il tipo record, valorizzato in fase di generazione del record, da utilizzare per le tutte le operazioni di alimentazione e aggiornamento della base dati regionale. Successivi rinvii dello stesso record devono utilizzare lo stesso progressivo. Progressivi record inviati in un trimestre, se non presenti in successivi invii, si intendono annullati.

**** Tutti i campi obbligatori vanno compilati anche in caso di rivalutazione***

	B2 TRACCIATO SOSPENSIONI più righe per evento assistenziale di CD (facoltativo - possibili più records nel periodo in esame)								
	Nr. Rif. Campo	Chiave tab.	Obbligat orio	Descrizione campo	Lunghe zza	Posizione iniziale	Tipo Dato	Obbligatori o NSIS-ADI	Istruzioni per la codifica
	3.1	**X**	SI	**Identificativo evento assistenziale di CD**	12	1	N	SI	Ricollega il servizio erogato all'evento assistenziale di CD (vedi TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
Sospensione	*3.2*		SI	**Data inizio sospensione**	8	13	D	SI	Indica la data in cui inizia la sospensione dell'erogazione delle cure domiciliari all'assistito.
	3.3		FAC	**Data fine sospensione**	8	21	D	FAC	Indica la data in cui termina la sospensione dell'erogazione delle cure domiciliari all'assistito.
	3.4		SI	**Motivo sospensione**	1	29	N	SI	I valori ammessi sono: 1 - ricovero in ospedale, 2 - allontanamento temporaneo, 3 - ricovero temporaneo in struttura residenziale, 4 - ricovero in HOSPICE, 7 - ricovero in altra struttura residenziale/intermedia, 9 - altro.
	3.5	**X**	SI	**Chiave Progressivo record**	12	30	N	NO	Identificativo univoco assoluto per il tipo record, valorizzato in fase di generazione del record, da utilizzare per le tutte le operazioni di alimentazione e aggiornamento della base dati regionale. Successivi rinvii dello stesso record devono utilizzare lo stesso progressivo. Progressivi record inviati in un trimestre, se non presenti in successivi invii, si intendono annullati.

	C. TRACCIATO ACCESSI più righe per evento assistenziale di CD (almeno un record per ogni evento assistenziale di CD nel periodo in esame)							
Nr. Rif. Campo	Chiave tab.	Obbligatorio	Descrizione campo	Lunghezza	Posizione iniziale	Tipo Dato	Obbligatorio NSIS-ADI	Istruzioni per la codifica
4.1	**X**	SI	**Identificativo evento assistenziale di CD**	12	1	N	SI	Ricollega il servizio erogato all'evento assistenziale di CD (vedi TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
4.2	**X**	SI	**Data accesso**	8	13	D	SI	Utilizzare il formato GGMMAAAA
4.3		SI	**Numero accessi nella stessa data**	1	21	N	SI	indica il numero di accessi della stessa figura professionale nella stessa data
4.4	**X**	SI	**Tipo accesso**	1	22	N	SI	Valori ammessi:1 - programmato Si, 2 - programmato No, **9 - non disponibile***
4.5	**X**	SI	**Figura professionale che effettua l'accesso domiciliare**	2	23	N	SI	valori ammessi: 1 - MMG, 2 - PLS, 3 - infermiere, 4 - medico specialista, 5 - medico esperto in cure palliative, 6 - medico di continuità assistenziale, 7 - psicologo, 8 - fisioterapista, 9 - logopedista, 11 - dietista, 12 - assistente sociale della Az. ULSS (del SSN), 13 - assistente sociale del Comune (no del SSN), 14 - terapista occupazionale, 15 - Medico USCA (non valido per PIC iniziate dal 2025), 56 – infermiere solo prelievo, 60 – OSS della Az. ULSS (del SSN), 61 – OSS del comune (no del SSN), 70 - Infermiere di famiglia o di comunità, 71 -UCAD Medico Continuità Assistenziale Diurna, 99 - altro soggetto.
4.6		NO	**Tipo di accessi MMG/PLS**	1	25	N	NO	1 - adimed, 2 - programmata, 3 - malati oncologici*, 9 - altro *Assistenza dei malati oncologici, o affetti da malattie inguaribili, nelle ultime fasi della vita, DGR 3889 del 31/12/2011
4.7		SI	**Sede dell'accesso**	1	26	N	NO	sede: 1 - a domicilio, 2 – in ospedale (dimissioni protette), 3 – a domicilio per visita di cordoglio, 4 - altro, 5 - a distanza, 6 - OdC o Centro Servizi. Il ricovero ordinario preclude la possibilità di fare accessi con codifica 1; il decesso preclude la possibilità di fare accessi con codifica 1-2-4-5-6)
4.8		NO	**Titolarità della gestione**	1	27	N	NO	valori ammessi: 1 - gestione in appalto, 2 - gestione pubblica (prevale se compresenti nella stessa giornata per la specifica figura che effettua l'accesso), 3 – volontariato.
4.9		NO	**Branca assistenza specialistica domiciliare**	3	28	N	NO	Da utilizzare solo per il servizio 4 = medico specialista; utilizzare il codice definito nella tabella allegata, già utilizzato nel modulo assist. specialistica ambulatoriale
4.10		NO	**Durata dell'accesso (in minuti)**	3	31	N	NO	Da utilizzare solo per OSS da esprimere in minuti. Nel caso di unico accesso effettuato da 2 o più operatori, sommare i minuti dell'accesso
4.11	**X**	SI	**Chiave Progressivo record**	12	34	N	NO	Identificativo univoco assoluto per il tipo record, valorizzato in fase di generazione del record, da utilizzare per le tutte le operazioni di alimentazione e aggiornamento della base dati regionale. Successivi rinvii dello stesso record devono utilizzare lo stesso progressivo. Progressivi record inviati in un trimestre, se non presenti in successivi invii, si intendono annullati.

	D. TRACCIATO PRESTAZIONI più righe per evento assistenziale di CD (almeno un record per ogni accesso dell'evento assistenziale di CD nel periodo in esame)							
Nr. Rif. Campo	Chiave tab.	Obbligatorio	Descrizione campo	Lunghezza	Posizione iniziale	Tipo Dato	Obbligatorio NSIS-ADI	Istruzioni per la codifica
5.1	**X**	SI	**Identificativo evento assistenziale di CD**	12	1	N	SI	Ricollega il servizio erogato all'evento assistenziale di CD (vedi TRACCIATO DATI ANAGRAFICI)
5.2	**X**	SI	**Data accesso**	8	13	D	SI	Utilizzare il formato GGMMAAAA
5.3	**X**	SI	**Tipo accesso**	1	21	N	SI	Valori ammessi:1 - programmato Si, 2 - programmato No, **9 - non disponibile***
5.4	**X**	SI	**Figura professionale che effettua l'accesso domiciliare**	2	22	N	SI	valori ammessi: 1 - MMG, 2 - PLS, 3 - infermiere, 4 - medico specialista, 5 - medico esperto in cure palliative, 6 - medico di continuità assistenziale, 7 - psicologo, 8 - fisioterapista, 9 - logopedista, 11 - dietista, 12 - assistente sociale della Az. ULSS (del SSN), 13 - assistente sociale del Comune (no del SSN), 14 - terapista occupazionale, 15 - Medico USCA (non valido per PIC iniziate dal 2025), 56 – infermiere solo prelievo, 60 – OSS della Az. ULSS (del SSN), 61 – OSS del comune (no del SSN), 70 - Infermiere di famiglia o di comunità, 71 -UCAD Medico Continuità Assistenziale Diurna, 99 - altro soggetto.
5.5		SI	**Tipo Prestazione**	2	24	N	SI	Indica le informazioni inerenti le prestazioni.I valori ammessi sono: 1 - Visita domiciliare (comprensiva di valutazione clinica/funzionale/ sociale e monitoraggio) 2 - Prelievo ematico 3 - Esami strumentali 4 - Trasferimento competenze/educazione del care giver/colloqui/nursering/ addestramento 5 - Supporto psicologico équipes-paziente-famiglia 6 - Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione 7 - Terapia infusionale SC e EV 8 - Emotrasfusione 9 - Paracentesi, Toracentesi e altre manovre invasive, gestione di cateteri spinali o sistemi di neuromodulazione del dolore 10 - Gestione ventilazione meccanica - tracheostomia - sostituzione canula - broncoaspirazione - ossigenoterapia 11 - Gestione nutrizione enterale (SNG PEG) 12 - Gestione nutrizione parenterale - gestione cvc 13 - Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie 14 - Gestione alvo comprese le enterostomie 15 - Igiene personale e mobilizzazione 16 - Medicazioni semplici 17 - Medicazioni complesse 18 - Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici 19 - Trattamento di rieducazione motoria – respiratoria 20 - Trattamento di rieducazione del linguaggio 21 - Trattamento di rieducazione dei disturbi neuropsicologici 22 - Controllo dolore 23 - Controllo dispnea 24 - Controllo sintomi gastro enterici (nausea, vomito, ecc.) 25 - Controllo sintomi psicocomportamentali (ansia,angoscia, agitazione, delirium, ecc.) 26 - Sedazione terminale/palliativa 27 - Gestione di quadri clinici complessi (fistole, masse ulcerate, stomie, drenaggi,vaste lesioni cutanee, etc.) 28 - Accudimento del paziente (con autonomia ridotta o assente) 71 - Televisita 72 - Teleassistenza 73 - Telemonitoraggio 74 - Teleconsulto/Teleconsulenza **99 - non disponibile ***
5.6		FAC	**Numero Prestazioni**	2	26	N	FAC	Indica il numero di prestazioni erogate a domicilio nel caso in cui lo stesso operatore effettua nello stesso giorno più accessi con la stessa tipologia di prestazione.
5.7	**X**	SI	**Chiave Progressivo record**	12	28	N	NO	Identificativo univoco assoluto per il tipo record, valorizzato in fase di generazione del record, da utilizzare per le tutte le operazioni di alimentazione e aggiornamento della base dati regionale. Successivi rinvii dello stesso record devono utilizzare lo stesso progressivo. Progressivi record inviati in un trimestre, se non presenti in successivi invii, si intendono annullati.

LEGENDA:

campi che riportano delle variazioni in riferimento alle spcifiche ministeriali v 7.4

**** il valore "non disponibile" è da utilizzare in via eccezionale solo nei casi in cui l'informazione non sia reperibile in alcun modo.***

Regione del Veneto - SIAD - ADI

(Sistema Informativo Assistenza Domiciliare e Cure Palliative)

CLASSIFICAZIONE PROBLEMI DI SALUTE / BISOGNI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Problemi di salute	Bisogni e prestazioni assistenziali	Posizione
Progettualità assistenziale	Valutazione monoprofessionale	1
	Valutazione multidisciplinare	2
Rischio infettivo	Interventi di educazione terapeutica teorica e pratica / counselling *(almeno 15 minuti)*	3
	Assistenza per rischio infettivo e gestione procedure di prevenzione	4
Respiratori	Interventi di educazione terapeutica teorica e pratica / counselling *(almeno 15 minuti)*	5
	Gestione O_2 terapia	6
	Gestione tracheostomia	7
	Gestione ventilazione invasiva	8
	Gestione broncoaspirazione / drenaggio posturale	9
Alimentazione	Interventi di educazione terapeutica teorica e pratica / counselling *(almeno 15 minuti)*	10
	Gestione alimentazione per OS	11
	Gestione S.N.G.	12
	Gestione P.E.G.	13
	Gestione alimentazione parenterale	14
Eliminazione urinaria/intestinale	Interventi di educazione terapeutica teorica e pratica / counselling *(almeno 15 minuti)*	15
	Gestione cateterismo vescicale	16
	Gestione urostomia	17
	Dialisi	18
	Clistere evacuativo	19
	Gestione stomia (ileo/colon)	20
Integrità cutanea	Interventi di educazione terapeutica teorica e pratica / counselling *(almeno 15 minuti)*	21
	Trattamenti lesioni decubito I e II grado	22
	Trattamenti lesioni decubito III e IV grado	23
	Trattamenti lesioni decubito III e IV grado multiple	24
	Trattamenti ulcere trofiche	25
	Trattamenti ferite chirurgiche	26
Riposo/sonno	Assistenza per alterazione del ritmo sonno veglia	27
Dolore	Gestione dolore (oncologico e non oncologico)	28
Terminalità	Assistenza relativa allo stato di terminalità oncologica	29
	Assistenza relativa allo stato di terminalità non oncologica	30
Stress del Caregiver	Supporto al caregiver (compreso supporto al lutto)	31
Alterazione della relazione, del coping e della tolleranza allo stress	Supporto al paziente	32
Procedure diagnostiche	Interventi di educazione terapeutica teorica e pratica / counselling *(almeno 15 minuti)*	33
	Rilevazione parametri vitali e fisici	34
	Prelievo venoso (non occasionale)	35
	Prelievo materiale organico per microbiologia	36
	Prelievo arterioso per emogasanalisi	37
	E.C.G.	38
	Telemetria	39
Procedure terapeutiche	Interventi di educazione terapeutica teorica e pratica / counselling *(almeno 15 minuti)*	40
	Terapia intramuscolare e sottocutanea	41
	Gestione C.V.C. / Porth-cath	42
	Gestione terapia infusiva periferica	43
	Gestione cateterismo peridurale	44
	Gestione terapia con microinfusori / elastomeri	45
	Trasfusioni	46
disabilità / handicap con potenziale residuo	Prescrizione, addestramento, collaudo ausili	47
	Trattam. riabilitativo post acuto paz. Neurologico	48
	Trattam. riabilitativo post acuto paz. Ortopedico	49
	Trattam. riabilitativo post acuto paz. altre patologie	50
	Trattamento patologie della comunicazione	51
	Trattamento riattivativo di sindr. da allettamento recente	52
	Cicli riabilitativi di mantenimento in presenza di disabilità per prevenzione di complicanze	53
	Educazione ed addestramento	54
disabilità / handicap	Supervisione continua	55
	Assistenza nelle ADL *(bagno, igiene, vestirsi, mangiare, trasferimenti)*	56
	Assistenza nelle iADL *(pulizia casa, acquisti, preparazione pasti, lavanderia)*	57
	Accompagnamento/trasporti fuori casa	58
Covid	Covid	59
Cure Palliative	se il paziente al momento dell'attivazione dell'UCPDOM presenta un'aspettativa di vita presumibilmente molto breve (per adulto Karnosfky < = 30) tale da richiedere un immediato PAI di Cure di Fine Vita e non di Cure Palliative "standard" **NBB: Il campo deve essere valorizzato solo se tipo presa in carico = UCPDOM**	60
(da definire)	vuoto	61
	vuoto	62
	vuoto	63
	vuoto	64
	vuoto	65
	vuoto	66
	vuoto	67
	vuoto	68
	vuoto	69
	vuoto	70

la valorizzazione dei campi relativi ai bisogni assistenziali è obbligatoria ancnhe in caso di rivalutazione

Tabella 1 - Segni e sintomi clinici

Si ricorda che il campo Segno/Sintomo clinico nel tracciato deve essere riportato con i soli valori numerici senza il punto (max 5 caratteri).

Segno/Sintomo	Codifica ICD 9 CM
Affezioni pruriginose non specificate (Prurito SAI)	698.9
Alterazione (o perdita) temporanea della coscienza (Confusione)	780.02
Altra e specificata ritenzione urinaria	788.29
Altra incontinenza urinaria	788.39
Altra Stipsi	564.09
Altre alterazioni della coscienza (Sonnolenza, sopore, stupore)	780.09
Altre dispnee e anomalie respiratorie	786.09
Altro dolore Toracico	786.59
Altro intasamento dell‟intestino (Subocclusione/Occlusione intestinale)	560.39
Altro malessere ed affaticamento (Astenia SAI)	780.79
Anoressia (Perdita di appetito)	783.0
Ascite	789.5
Cachessia	799.4
Cefalea	784.0
Cervicalgia (Dolore Capo-Collo)	723.1
Cianosi	782.5
Coma	780.01
Cure palliative	V66.7
Delirium da condizioni patologiche classificate altrove	293.0
Diarrea	787.91
Dolore Addome di altre sedi specificate	789.09
Dolore correlato a neoplasia (acuto, cronico)	338.3
Dolore degli arti	729.5
Dolore Generalizzato	780.96
Ecchimosi spontanee	782.7
Edema (cute)	782.3
Ematemesi	578.0
Emoftoe	786.3
Espettorato abnorme	786.4
Emorragia del retto e dell‟ano	569.3
Emorragia non specificata	459.0
Incontinenza fecale	787.6
Insonnia non specificata	780.52
Iperidrosi generalizzata (Sudorazione eccessiva)	780.8
Ittero non specificato	782.4
Melena e rettorragia	578.1
Movimenti involontari anormali (Tremori)	781.0
Nausea (solo)	787.02
Oliguria, anuria	788.5
Rachialgia dorsale (Dolore Rachide)	724.1
Singhiozzo	786.8
Difficoltà dell'alimentazione ed errori nella somministrazione degli alimenti	783.3
Dimagrimento anomalo	783.21
Sottopeso	783.22
Polidipsia	783.5
Disfagia	787.2
Dispepsia e altri disturbi specificati della funzione gastrica	536.8
Disturbi del sonno non specificati	780.50
Disturbi della secrezione salivare (Xerostomia-Scialorrea)	527.7
Disturbi della sensibilità cutanea	782.0
Disturbo distimico (depressione reattiva, scadimento di umore)	300.4
Stati di ansia non specificato (Ansia)	300.00
Stordimento e capogiro (Vertigini)	780.4
Tosse	786.2
Ulcerazione da decubito (altri siti)	707.09
Vomito (solo)	787.03
Vomito con nausea	787.01
Atri segni o sintomi	Codificare con ICD9 CM
Abitazione inadeguata	V60.1
Altre ragioni per entrare in contatto con i servizi (Scelta del malato come luogo di assistenza)	V65.8
Assenza del caregiver	V60.4
Persona che vive da solo	V60.3
Problema psicosociale non specificato (sofferenza psicoesistenziale)	V62.9
Ricovero di sollievo temporaneo (famiglia)	V60.5
Altri motivi non clinici	Codificare con ICD9 CM